

Pediatria Sp Temp

Resumed™ - Pediatria São Paulo

Introdução

Bem-vindos ao Resumed™ de **Pediatria**! Este guia foi elaborado com base nas provas de **USP-SP, Unifesp, Unicamp, Santa Casa e SUS-SP**, cruzando os temas mais incidentes com os livros clássicos (*Nelson, SBP*) e diretrizes do Ministério da Saúde. Organizado por grandes áreas pediátricas, traz explicações práticas, fluxos de decisão e checklists para revisão final.

Neonatologia

Triagem Neonatal

Teste do Pezinho: 3º ao 5º dia de vida - Detecta fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, fibrose cística, hemoglobinopatias, etc.

Reanimação Neonatal (2022)

Indicações: FC <100, respiração irregular Sequência: 1. Aquecer, posicionar, aspirar se necessário 2. VPP com máscara + oxigênio (21%) 3. Massagem se FC <60 4. Adrenalina se refratário

Icterícia Neonatal

<24h: patológica (investigar incompatibilidade ABO/Rh)

24h até 7 dias: fisiológica Tto: fototerapia,
exsanguínea se grave

Crescimento e Desenvolvimento

Marcos do Desenvolvimento

- 2 meses: sorriso social
- 6 meses: senta com apoio, balbucia
- 9 meses: senta sem apoio, estranha
- 12 meses: anda com apoio, 1 palavra
- 18 meses: anda bem, 5 palavras, empilha 3 cubos

Avaliação Nutricional

Curvas da OMS (peso x idade, altura x idade) Desnutrição grave: <-3 escore-z Obesidade: $>+2$ escore-z

Imunizações (PNI)

- BCG: ao nascer (cicatriz = resposta)
- Hep B: ao nascer, 2ª, 3ª dose
- Penta: DTP + Hib + Hep B
- VIP/VOP: esquema de 3 + reforço
- Pneumo 10, Meningo C, Rotavírus, Tríplice viral (12m + reforço)
- DTP reforço com 15 meses e 4 anos

Infectologia

Doenças Exantemáticas

- Sarampo: febre alta, tosse, Koplik → rash céfalo-caudal
- Rubéola: rash + linfadenomegalia retroauricular
- Exantema súbito: febre → erupção súbita após defervescência
- Eritema infeccioso: "bofetada" + reticular
- Varicela: lesões em vários estágios (pápula, vesícula, crosta)

Infecções de vias aéreas

- Laringite viral: tosse metálica, estridor → adrenalina + corticoide
- Bronquiolite: <2 anos, VSR, sibilância → suporte
- Pneumonia:
 - <2m: ATB sempre (ampicilina + gentamicina)
 - > 2m: ambulatorial (amoxicilina)

Gastroenterologia Pediátrica

Diarreia Aguda

Causa principal: rotavírus Sinais de desidratação: * Plano A: hidratação oral * Plano B: SRO em observação * Plano C: hidratação EV (Ringer lactato)

Constipação

Retenção voluntária, dor, escape fecal Tto: lactulose, PEG, reeducação alimentar

Pneumologia Pediátrica

Asma

Intermitente: <2x/sem Persistente leve/moderada/grave Tto: * Leve: SABA * Moderado: CI + SABA * Grave: CI alta + LABA

Corpo Estranho

Súbito, tosse + estridor unilateral Dx: radiografia (nem sempre mostra) Conduta: broncoscopia rígida

Hematologia

Anemia Ferropriva

Mais comum na infância Triagem: 12 meses Profilaxia: ferro oral a partir de 6 meses Tto: 3–5 mg/kg/dia de ferro elementar

Doença Falciforme

Triagem neonatal Crises vaso-oclusivas: dor, infarto esplênico Tto: analgésico, hidratação, hidroxiureia

Endocrinologia

Hipoglicemia Neonatal

Glicemia <45 mg/dL Fatores de risco: RN PIG, GIG, filhos de diabética Tto: glicose EV

Puberdade Precoce

<8 anos (meninas), <9 anos (meninos) Central (GnRH-dependente) x periférica Conduta: GnRH análogo (central), tratar causa (periférica)

Urgências e Emergências

Convulsão Febril

6m – 5 anos Generalizada, <15 min Tto: diazepam retal se >5 min Profilaxia se recorrente

Sepse Neonatal

Precoce: GBS, E. coli Tardia: S. aureus, Gram– Tto: ampicilina + gentamicina / cefotaxima

Mapas Mentais

🧠 Diarreia aguda – conduta

- Sem sinais → plano A (hidratar em casa)
- Olhos fundos, sede → plano B (SRO observação)
- Letárgico, hipotenso → plano C (EV)

🧠 Vacinas do 2º mês

- Penta (DTP + Hib + Hep B)
- VIP
- Pneumo 10
- Rota
- Meningo C

🧠 Crise asmática

- Leve: SABA + observar
- Moderada: SABA + corticoide VO
- Grave: SABA contínuo + corticoide EV
- Refratária: sulfato de magnésio, VMI

Checklist Final

- [] Testes de triagem neonatal (nome + dia + doenças)
- [] Reanimação neonatal e icterícia
- [] Padrões de desenvolvimento por idade
- [] Esquema de vacinas (2º, 4º, 6º mês e reforços)
- [] Conduta na bronquiolite e pneumonia
- [] Planos A, B e C de diarreia
- [] Anemia ferropriva e falciforme
- [] Puberdade precoce (central x periférica)

Dicas Resumed™

⚠️ Teste do pezinho CAI. Decore doenças + dia. Diarreia SEM desidratação? Plano A e tchau. Simples. Bronquiolite = não usar ATB nem broncodilatador. Vacinas são checklist puro: revise esquema mês a mês. Sepsis neonatal = ampi + genta. De novo. Ampicilina + gentamicina.

Referências

Obrigatórias: * Nelson – Tratado de Pediatria * Tratado de Pediatria – SBP * Cadernos de Atenção Básica – MS * PNI – Programa Nacional de Imunizações * Reanimação Neonatal – SBP 2022